

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
ASIGNATURA TÉCNICAS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA I



INVENTARIO MULTIFÁSICO DE PERSONALIDAD DE MINNESOTA, MMPI

(Características generales, guía para la interpretación
escalas clínicas y escalas adicionales)

Apunte de circulación restringida para uso docente en la
asignatura de Técnicas de Evaluación Psicológica I
CIUDAD UNIVERSITARIA - 2002

INVENTARIO MULTIFÁSICO DE PERSONALIDAD DE MINNESOTA, MMPI

Características Generales del Inventario MMPI

El Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (Minnesota Multifasic Personality Inventory, MMPI) explora distintos aspectos de la personalidad y al mismo tiempo. Es un inventario que incluye distintas escalas, cada una de ellas destinada a medir un aspecto específico.

En 1940, Hathaway y McKinley publican un primer artículo referente a este inventario. El objetivo era detectar trastornos de conducta severos o de personalidad y, por tanto, las escalas apuntan a medir estos constructos de acuerdo a la realidad clínica de la época.

Para diseñar el inventario se trabajó con muestras clínicas previamente diagnosticadas contrastados con sujetos normales. En forma posterior, las muestras fueron tomadas con mayor rigurosidad.

La versión original poseía pocas escalas, siendo en las revisiones posteriores en donde se agregaron más. En la versión original se tenía: 10 escalas clínicas, 3 escalas de validación y 564 ítems. En cambio, la versión actual (MMPI-2) cuenta con 567 ítems.

La prueba debe aplicarse a sujetos con un nivel de educación primaria (8º básico), ya que los reactivos requieren por lo menos que el sujeto al que se le aplique sepa leer, además de un cierto nivel de comprensión lectora, de tal manera que las respuestas puedan ser aceptadas.

Otras Características del MMPI

Los puntajes que obtienen los sujetos en cada una de las escalas se transforman a puntuaciones T (escala de puntaje estándar con media = 50 ds = 10).

En las escalas en las que el sujeto obtiene un puntaje T mayor o igual a 70 ó menor o igual a 30 se considera que el puntaje es de interés clínico (ver las tablas correspondientes a cada escala).

La versión original se sigue usando, pero se han agregado nuevas escalas a través de nuevas combinaciones de ítems (no más ítems), que se consideran escalas adicionales. Algunas escalas son de tipo clínico, y otras buscan características de personalidad que no reportan mayor interés en la clínica, como por ejemplo, la escala de responsabilidad.

Entre las escalas adicionales más importantes se cuentan: la escala MAC, que intenta medir conductas adictivas; la escala Es, que mide fuerza del yo desde el punto de vista psicoanalítico y se relacionaría con la escala de histeria, de psicopatía y de psicastenia; la escala OH, o escala de hostilidad sobrecontrolada, que debería asociarse con un puntaje alto en Es y con la tríada neurótica, es decir, las escalas de hipocondría, histeria y psicastenia. Más adelante comentamos algunas escalas adicionales importantes.

Pasos para la interpretación del MMPI

La formación de hipótesis interpretativas mediante el perfil obtenido por el MMPI depende de tres factores relacionados entre sí: la aceptabilidad de los puntajes del perfil; la elevación absoluta de las escalas componentes en comparación con los puntajes T estándar indicados en el manual; y las configuraciones relativas de aquellos puntajes en el perfil de un mismo individuo. Estas últimas reflejan la confiabilidad y los patrones de interrelación entre las escalas componentes.

Una aproximación ordenada para analizar el perfil que entrega el MMPI incluiría los siguientes pasos a seguir:

- 1) Evaluar la aceptabilidad del protocolo para la interpretación individual, mediante las escalas de validez del inventario. También se puede evaluar la aceptabilidad mediante algunas observaciones acerca de la situación de examen, así como también comparando hasta que punto la información obtenida por el test es consistente con datos anteriores relativos al individuo examinado.
- 2) Examinar los puntajes de las escalas clínicas, para poder generar líneas de interpretación acerca de la personalidad y funcionamiento emocional del individuo.
- 3) Consultar varias guías interpretativas del MMPI, para buscar correlatos comunes con los patrones generados por el perfil clínico, incluyendo además posibles diagnósticos alternativos.
- 4) Determinar, al menos en las escalas que están elevadas a un nivel promedio-superior, los componentes subescalares principales que influyen en aquellas elevaciones, destacando los resultados más interesantes del test del individuo.
- 5) Destacar cualquier ítem significativo que pudiera estar asociado con problemas especiales, o con cualquier síntoma previamente insospechado o de interés.

Escalas de Validación

El propósito de las escalas de validación es señalar el grado de confiabilidad con que se pueden hacer inferencias acerca de la personalidad, con base en el perfil de la prueba. En realidad, estas escalas se refieren principalmente a la actitud que el sujeto toma al contestar la prueba. Esta actitud está basada en el grado de conformidad con el grupo dentro del cual funciona el examinando, en el proceso de socialización y en el estado de salud mental con que se encuentre. Por eso, es importante recordar que las escalas de validación de la prueba, en tanto muestra de la conducta del sujeto, ofrecen información útil para evaluar la personalidad del mismo.

Las escalas de validación son de distinto tipo:

- El puntaje de la **escala de ausencia de respuestas** no se trata de una escala en el sentido usual, sino que consiste en el simple conteo de los ítems que el sujeto dejó sin responder. El límite de respuestas omitidas aceptable es 30 ítems o más del total, en cuyo caso el protocolo se considera altamente sospechoso, cuando no completamente inválido, ya que no sería posible obtener un perfil del sujeto.

Escala de Ausencia de Respuestas			
Puntaje Bruto	Utilidad del perfil	Fuentes de elevación	Posibilidades interpretativas
Alto (30 y superior)	Probablemente inválido.	Problemas severos de lectura o dislexia. Retardo psicomotor. Confusión. Oposicionismo. Indecisión.	Depresión severa. Estado obsesivo.
Promedio-Superior (11-29)	Validez cuestionable.	Problemas leves de lectura. Falta de experiencia. Cautela exagerada.	Poca familiaridad con el idioma español. Ideación paranoide.
Modal (2-10)	Probablemente válido. (revisar el contenido para detectar omisión selectiva)	Interpretación idiosincrática de la prueba.	
Bajo (0-1)	Válido.		

- **La escala de mentira (L)**, contiene ítems que apuntan a situaciones de faltas menores, en las que la mayoría de las personas ha incurrido. En este sentido, se puede decir que la escala expresa opiniones y conductas que al ser evaluadas, solamente se encuentran en personas muy conscientes, demasiado conscientes. Por tanto, lo que se persigue es verificar si el sujeto pretende mostrar una personalidad “perfecta”, con ajuste a lo ideal, cubriendo sus faltas personales, socialmente inaceptables.

La escala L se refiere a la franqueza del sujeto al contestar la prueba, y no puede ser usada como indicadora de tendencia general hacia la mentira.

Escala de mentira (escala L)			
Nivel de puntuación T	Utilidad del perfil	Fuentes de elevación	Posibilidades interpretativas
Muy Alto (80 y superior)	Probablemente inválido.	Finge un buen ajuste.	Resistencia al test o ingenuidad.
Alto (70-79)	Validez cuestionable.	Respuestas al azar. Negación de faltas.	Estado confusional. Estilo represivo. Falta de insight.
Promedio-Superior (60-69)	Probablemente válido.	Configuración defensiva.	Sobre-convencionalismo y conformismo. Moralismo. Rígidamente virtuoso.
Modal (50-59)	Válido.	Acercamiento típico a la situación de test.	Comodidad con la propia autoimagen.
Bajo (49 e inferior)	Posiblemente, finge estar mal.	Todas las respuestas verdaderas.	Preocupación excesiva por lo patológico. Autoconfianza e independencia. Cínico, sarcástico.

- **La escala de infrecuencia (F, o de simulación)**, mide si el sujeto está simulando las respuestas, también considerada para verificar consistencia en las respuestas del sujeto. Sin embargo, el sujeto también puede tener un puntaje alto en esta escala por otros factores, como alteración de conciencia, deficiencia intelectual, poca escolaridad, etc.

Escala de Simulación (escala F)			
Nivel de puntuación	Utilidad del perfil	Fuentes de elevación	Posibilidades interpretativas
Muy Alto (91 y superior)	Probablemente inválido.	Respuestas al azar. Errores de puntuación. Dislexia severa.	No cooperativo, finge que está mal. Habilidades marginales de lectura. Resistencia al test.
Alto (71-90)	Validez cuestionable.	Fingir enfermedad. Procesos psicóticos. Todas las respuestas verdaderas.	Pedido de ayuda. Crisis de identidad en la adolescencia. Estado confusional.
Promedio-Superior (56-70)	Probablemente válido.	Deseo de ser no convencional. Compromisos políticos, sociales o religiosos muy fuertes. Retardo en la atención. Extremada honestidad al responder. Agitación en medio de una crisis.	Riesgo de acting-out agresivo. Irritabilidad, inquietud, inestabilidad. Psicopatología moderadamente severa. Autocrítico. Agitado, distraído.
Modal (45-55)	Protocolo aceptable.	Creencias un poco desviadas.	Buen funcionamiento. Respuesta típica al test.
Bajo (44 e inferior)	Protocolo aceptable.	Conformidad. Posiblemente finge estar bien.	Convencional. Sincero. Conforme socialmente.

- **La escala de corrección (K, o de deseabilidad social)**, contiene una serie de ítems que desde un punto de vista social serían conductas poco deseables. Lo que se busca es si el sujeto está mostrando una postura de aceptación social. Luego, los puntajes se asocian a algunas escalas clínicas como las de hipocondría, trastorno psicopático, etc. Constituiría un puntaje de corrección que permitiría hacer ajustes a otras escalas.

Escala de Corrección (escala K)		
Nivel de puntuación T	Fuentes de elevación	Posibilidades interpretativas
Alto (71 y superior)	Marcadamente defensivo. Finge que está bien. Todas las respuestas falsas. Estado de defensa en situaciones de empleo.	Timidez, inhibición, falta de compromiso emocional. Confianza en la negación. Falta de insight.
Promedio-Superior (56-70)	Moderadamente defensivo. No reconocimiento del estrés.	Adaptado. Con autoconfianza. Sin intención de buscar ayuda.
Modal (41-55)	Equilibrio entre la auto-protección y la auto-revelación.	Recursos suficientes para una intervención.
Bajo (40 e inferior)	Respuestas para fingir que se está mal. Todas las respuestas verdaderas. Pedido de ayuda. Defensas inadecuadas.	Cinismo, escepticismo. Estado de pánico. Pobreza de autoconcepto. Crítico de sí mismo y de los otros.

Configuraciones de las Escalas de Validación

Las escalas de validación deben ser consideradas en conjunto para tomar decisión en cuanto a la validez del perfil general. Por ejemplo, la escala L puede presentar un alto puntaje no porque el individuo quiera mentir, sino porque es rígido en el plano ético-moral. Por este motivo, se han descrito varias configuraciones de las escalas de validación útiles para la interpretación y el diagnóstico, que deben ser confrontadas con el resto del perfil clínico.

En las configuraciones que ofrecen las tres escalas L, F y K, generalmente una de ellas es alta y las otras dos alcanzan una puntuación próxima a T 50. Cuando L es la escala más alta y las otras dos son bajas, alrededor de T 50, esta configuración se encuentra en protocolos de sujetos de poca escolaridad que intentan ofrecer un cuadro ingenuo extremadamente favorable al interpretar la prueba. Cuando F es la puntuación más alta y las otras dos escalas se encuentran cerca de T 50, generalmente son protocolos de personas con un cuadro agudo de perturbación emocional, y las respuestas a F parecen estar relacionadas con una solicitud de ayuda por parte del paciente (perfil de grito de ayuda). Cuando K es la puntuación más alta, y las otras dos escalas se encuentran cerca de la línea media, se trata de personas que utilizan evasiones defensivas a fin de aparecer bien o de aparentar que nada les pasa.

Cuando la L y la K se encuentran por encima de F, y la F cerca o debajo de la media (T 50), se trata de perfiles de sujetos normales defensivos o de pacientes histeroideos o hipocondríacos. Esta combinación refleja un intento franco de no revelar sentimientos socialmente rechazables.

Si los valores de L y K son inferiores a la media (T 50) y F es alta, se trata de un perfil en el que se intenta deliberadamente presentar un cuadro falso de personalidad, pero también se encuentra en pacientes psicóticos agudos que muestran esta configuración como parte de su cuadro clínico, en protocolos de sujetos que contestan todas las frases como ciertas.

En ciertos casos, las escalas L, F y K son simultáneamente altas. Este tipo de casos se encuentra en protocolos en que el sujeto contesta todas las frases como falsas, o también en sujetos neuróticos altamente negativistas, pero más frecuentemente se encuentra entre pacientes esquizofrénicos agudos, en los que la elevación de las escalas de validez se debe al cuadro psicótico que presentan.

Otras Escalas de Validez

Como fruto de investigaciones posteriores se han propuesto otras escalas de validez del MMPI (perfiles K + normales, índice F-K de Gough, índice de repetición de frases, etc.); así como también se han descrito algunos perfiles distorsionados obtenidos por conjuntos específicos de respuesta (perfil contestado al azar, todas verdaderas en la prueba completa, todas falsas en la prueba completa, fingimiento de perturbación emocional, índice de fingimiento moderado, intento deliberado de aparentar ausencia de patología, etc.).

Escalas clínicas:

Escala 1 (Hs) de Hipocondría: Esta medida fue desarrollada con un grupo de pacientes neuróticos que mostraban una excesiva preocupación por su salud, presentaban una variedad de síntomas somáticos con pequeña o nula base orgánica, y comprobaciones repetidas de que no tienen nada malo físicamente. Algunos de los ítems de esta escala se refieren a síntomas particulares o quejas específicas, pero muchos otros reflejan una preocupación más general por lo corporal, o un autocentramiento en la vida de aquellos individuos.

Escala 1 de (Hs) Hipocondría	
Nivel de puntuación T	Posibilidades interpretativas
Muy Alto (76 y superior)	Esquizoide; comportamiento bizarro o alucinaciones somáticas. Inmovilizado por múltiples síntomas y quejas.
Alto (66 – 75)	Exageración ante cualquier problema real. Autocentramiento y egoísmo extremo. Mordaz. Apariencia cínica, demandante. Actitudes derrotistas. Pesimista. Exageración de problemas físicos. Cambiante. Quejas múltiples.
Promedio-Superior (56 - 65)	Puede tener un desorden orgánico específico. Quejumbroso, irritable. Preocupación exagerada por la salud personal, por la dieta, el peso y funcionamiento corporal.
Modal (41 - 55)	Preocupación pequeña y no específica acerca del cuerpo o salud. Emocionalmente abierto y equilibrado. Realista y contactado con sus emociones.
Bajo (40 e inferior)	Puede pasar por alto signos o síntomas de enfermedad. Optimista, vigoroso. Capaz, efectivo.

Escala 2 (D) de Depresión: Esta escala fue desarrollada con pacientes psiquiátricos con varias formas de síntomas depresivos, principalmente en personas con reacciones depresivas o en fase depresiva de un trastorno maníaco-depresivo. Los ítems de la escala incluyen no sólo los sentimientos de minusvalía, pesimismo y desesperanza que caracterizan a este cuadro clínico, sino que además algunas características básicas de personalidad como hiper-responsabilidad, altas expectativas personales y reprocharse a sí mismo.

Escala 2 (D) de Depresión	
Nivel de puntuación T	Posibilidades interpretativas
Muy Alto (76 y superior)	Retirado, Agobiado con problemas, desesperanza. Culposos, Sentimientos de desvalorización e inadecuación. Preocupación por la muerte, suicidio. Desánimo, pensamiento y accionar enlentecido.
Alto (66 - 75)	Retirado, tímido, distante. Tristeza. Falta de energía. Incapacidad de Concentración, quejas físicas, problemas con los ritmos de sueño. Auto-depreciación, baja confianza en sí mismo, sentimiento de inadecuación. Estresado, miserable, disfórico.
Promedio-Superior (56 - 65)	Inhibido, irritable tímido, malhumorado. Desanimado, melancólico, infeliz, insatisfecho consigo mismo y con el mundo. Pesimista, preocupado. Introvertido, moralista, responsable, modesto.
Modal (41 - 55)	Conforme consigo mismo. Estable, bien balanceado. Realista.
Bajo (40 e inferior)	Activo y entusiasta, Alegre, optimista, Carencia de inhibición, bajo control. Libre de agitación emocional, autoconfianza.

Escala 3 (Hy) de Histeria: Esta escala fue construida con pacientes que exhibían algunas formas de desorden sensorial o motor para el cual no se había encontrado base orgánica. Algunos de los ítems miden síntomas de conversión o somatización, mientras que otros involucran problemas de negación o falta de ansiedad social, que se ve a menudo en individuos con estas defensas.

Escala 3 (Hy) de Histeria	
Nivel de puntuación T	Posibilidades interpretativas
Muy Alto (76 y superior)	Altamente sugestionable. Episodios súbitos de ansiedad y pánico. Desinhibido. Berrinches infantiles. Reacciones de vergüenza por el desarrollo de síntomas físicos.
Alto (66 - 75)	Usos de negaciones y disociaciones. Síntomas funcionales específicos y quejas. Ingenuo, pobre autoconciencia. Demandante e histriónico. Flirtatious
Promedio-Superior (56 - 65)	Autocentrado y superficial. Inmaduro y manipulador. Conforme y moralista. Necesidad de aprobación, inseguro. Demostrativo y extrovertido.
Modal (41 - 55)	Realista. Abierto a los sentimientos. Lógico, liderazgo.
Bajo (40 e inferior)	Cínico, porfiado. Socialmente aislado y apartado. Pocos intereses.

Escala 4 (Pd) de Desviación Psicopática: Esta escala de medición fue desarrollada con individuos que eran derivados a servicios psiquiátricos para clarificar por qué tenían problemas con la ley a pesar de no haber sufrido deprivación cultural, de tener una inteligencia normal y no presentar trastornos neuróticos o psicóticos asociados. (A pesar de su nombre, más bien mide trastorno de personalidad antisocial, tal como es especificado en el DSM-IV).

Escala 4 (Pd) de Psicopatía	
Nivel de puntuación T	Posibilidades interpretativas
Muy Alto (76 y superior)	Juicio pobre. Inestable. Irresponsable. Autocentrado e inmaduro. Conductas antisociales. Agresivo o atacante.
Alto (66 - 75)	Pobre tolerancia al aburrimiento o tedio. Problemas con la autoridad. Problemas maritales y laborales recurrentes. Rebelde y hostil. Reacciones emocionales superficiales (culpa, vergüenza). Abuso de sustancias. Historia de bajo nivel de logros. Relaciones superficiales.
Promedio-Superior (56 - 65)	Impulsivo y aventurero. Hedonista. Resentido. Desconfiado e impaciente. Sociable. Autoconfiado y asertivo. Imaginativo y creativo.
Modal (41 - 55)	Sincero. Confiado. Perseverante. Responsable.
Bajo (40 e inferior)	Convencional y rígido. No asertivo y pasivo. Moralista. Autocrítico. Sobrecontrolado.

Escala 5 (Mf) de Masculinidad-Femineidad: Esta escala trata de medir conductas y/o intereses que en la década de los '30 o '40 correspondían al estereotipo de lo masculino (se construyó con pacientes masculinos con sentimientos homoeróticos egodistónicos); esperándose puntajes altos para hombres y puntajes bajos para mujeres. Sin embargo, en la actualidad es frecuente que las mujeres tengan más intereses en cosas masculinas. No se relaciona con una determinada identidad sexual, sino con intereses e ideas cognitivas relacionadas con el género.

Escala 5 (Mf) de Masculinidad – Femineidad		
Nivel de puntuación T	Posibilidades interpretativas	
	Hombres	Mujeres
Muy Alto (H: 76 y superior; M: 70 y superior)	Patrón de interés tradicionalmente femenino. Conflictos acerca de la identidad sexual. Pasivo y afeminado. Inseguro en asertividad. Tendencias homoeróticas.	Patrón de interés tradicionalmente masculino. No amistosa. Dominante. Agresiva.
Alto (H: 66 - 75; M: 60 - 69)	Curioso y creativo. Tolerancia a los otros. Individualista. Intereses intelectuales. Empático.	Autoconfiada. Lógica. No emocional. Competitiva. Vigorosa.
Promedio-Superior (H: 56 - 65; M: 51 - 59)	Autocontrolado. Expresivo y demostrativo. Uso del sentido común. Intereses estéticos. Sensibilidad interpersonal.	Activa. Aventurera. Espontánea. Asertiva.
Modal (H: 41 - 55; M: 41 - 50)	Práctico. De trato fácil. Realista. Convencional.	Empática. Capaz. Competente. De trato fácil. Considerada. Idealista
Bajo (H: 40 e inferior; M: 40 e inferior)	Patrón de interés tradicionalmente masculino. Machista, crudo y agresivo. Temerario. Pocos intereses. Orientado a la acción. Autoconfiado.	Patrón de interés tradicionalmente femenino. Insegura y autodepreciativa. Pasiva y sumisa. Falta de ayuda. Dependiente. Autocompasiva y quejas sobre sí misma ¹ .

¹ Estos descriptores se aplicarían principalmente a mujeres con bajo nivel de educación. Las mujeres con alto nivel educativo, se podrían describir mejor como: capaces, conscientes, fuertes, inteligentes, consideradas, de trato fácil, autoconscientes y desprejuiciadas.

Escala 6 (Pa) de Paranoia: Fue desarrollada con pacientes que mostraban principalmente alguna condición o estado paranoide, aunque en la muestra se incluyó algunos pacientes con paranoia. Los ítems de la escala reflejan marcada sensibilidad interpersonal, tendencias a la malinterpretación de los motivos de los otros, e ideas persecutorias. También involucran pensamiento autoreferente e inseguridad.

Escala de Paranoia (Pa)	
Nivel de puntuación T	Posibilidades interpretativas
Muy Alto (76 y superior)	Desorden de pensamiento. Creencias erradas. Ideas de referencia. Vengativo y rencoroso. Pueden actuar en concordancia con sus alucinaciones.
Alto (66 - 75)	Airado y resentido. Desplazamiento de la responsabilidad y las críticas. Hostil y suspicaz. Rígido y terco. Malinterpretación de situaciones sociales.
Promedio-Superior (56 - 65)	Marcadamente sensible al desprecio y al rechazo. Defensivo en situaciones sociales iniciales. Moralista; se hace la víctima. Confiado hasta ser traicionado. Trabajo duro.
Modal (41 - 55)	Racional. Claridad de pensamiento. Cauto. Flexible.
Bajo (40 e inferior)	Balanceado y alegre. Prudente y evasivo. Despreciativo. Sospecha de trastorno paranoide.

Escala 7 (Pt) de Psicastenia: Esta escala fue desarrollada con pacientes que mostraban preocupaciones obsesivas, rituales compulsivos o temores excesivos del grupo neurótico descritas en aquel tiempo como psicastenia (debilidad en el control sobre las propias conductas y pensamientos, o falta de fuerza psíquica), pero que corresponden a la actual denominación de trastorno obsesivo-compulsivo. Mientras algunos de los contenidos de los ítems se refieren a esta sintomatología, la escala en su conjunto se orienta hacia la ansiedad generalizada y el estrés (o emocionalidad negativa), así como a la de altos estándares morales, responsabilización interna por cosas que resultan mal, y esquemas rígidos para el control de impulsos.

Escala 7 (Pt) de Psicastenia	
Nivel de puntuación T	Posibilidades interpretativas
Muy Alto (76 y superior)	Rumiación. Rituales rígidos. Agitación. Fobias supersticiosas. Sentimientos de culpa. Temeroso. Ansiedad. Depresión.
Alto (66 - 75)	Inseguridad y ansiedad. Preocupado y aprehensivo. Sentimientos de equivocación (de fallar). Marcadamente meticuloso e indeciso. Moralista. Tenso y miserable.
Promedio-Superior (56 - 65)	Responsable y consciente. Intellectualización. Trabajo duro. Ordenado y perfeccionista. Autocrítico. Introspectivo.
Modal (41 - 55)	Puntual. Confiable. Confiado. Adaptable. Bien organizado.
Bajo (40 e inferior)	Autoconfiado. Libre de inseguridades. Relajado y cómodo. Perseverante y eficiente.

Escala 8 (Sc) de Esquizofrenia: Esta escala fue desarrollada con pacientes que manifestaban diversas formas de trastorno esquizofrénico. Los ítems miden un amplio espectro de creencias extrañas y experiencias inusuales, así como también el funcionamiento psicológico característico de estos individuos.

Escala 8 (Sc) de Esquizofrenia	
Nivel de puntuación T	Posibilidades interpretativas
Muy Alto (76 y superior)	Desorden de pensamiento. Conductas excéntricas. Socialmente excluido. Contacto pobre con la realidad. Alucinatorio y autista.
Alto (66 - 75)	Creencias inusuales. Conductas bizarras. Retirado y alienado. No convencional. Dudas de sí mismo y confusión de identidad. Dificultades en la concentración y el pensamiento.
Promedio-Superior (56 - 65)	Poco interés por la gente. No práctico. Creativo e imaginativo. Preocupación religiosa.
Modal (41 - 55)	Adaptable. Capaz de relacionarse con otros. Bien ajustado.
Bajo (40 e inferior)	Convencional y conservador. Autocontrolado. Sumiso.

Escala 9 (Ma) de Hipomanía: Esta escala fue construida con pacientes en etapas tempranas de trastorno maníaco-depresivo. Los ítems están asociados a sensaciones eufóricas, extroversión y altas aspiraciones; pero más que todo la escala está asociada a conductas arriesgadas.

Escala 9 (Ma) de Hipomanía	
Nivel de puntuación T	Posibilidades interpretativas
Muy Alto (76 y superior)	Expansivo. Grandiosidad. Irritable. Control pobre del temperamento. Hiperactivo. Distractibilidad. Decisiones impulsivas. Confusión.
Alto (66 - 75)	Sobredimensionado. Actividad excesiva. Eufórico. Conversador. Incansable (sin descanso) y lábil. Compromisos superficiales. Impacientes.
Promedio -Superior (56 - 65)	Gregario y sociable. Pobre tolerancia al tedio. Amplitud de intereses. Trabajo intenso y efectivo. Orientado al logro. Emprendedor.
Modal (41 - 55)	Sociable y amigable. Responsable. Realista. Entusiasta. Equilibrado.
Bajo (40 e inferior)	Apático y pesimista. Fácilmente fatigable. Tímido y dependiente. Falta de energías. Autoconfianza pobre. Depresivo.

Escala 0 (Si) de Introversión Social: Esta escala fue desarrollada con muestras de estudiantes de colegio con puntajes extremos en otros instrumentos que medían extroversión e introversión social.

Escala de Introversión (Si)	
Nivel de puntuación T	Posibilidades interpretativas
Muy Alto (76 y superior)	Distanciado, apartado, lejano. Inseguro e indeciso. Rumiativo
Alto (66 – 75)	Introvertido. Tímido y reservado. Falta de autoconfianza. Malhumorado. Sumiso. Rígido.
Promedio-Superior (56 – 65)	Reservado. Autoeficiente. Serio. Cautó. Socialmente inepto.
Modal (45 - 55)	Activo. Energético. Amigable. Conversador. Equilibrado
Bajo (44 e inferior)	Cálido. Sociable y gregario. Autoconfiado y asertivo. Indulgente consigo mismo. Exhibicionista. Manipulador.

Características de algunos perfiles del MMPI

El conocimiento de los diferentes tipos de perfiles es de enorme utilidad en la labor del psicólogo clínico que maneja esta prueba. Estos diferentes tipos de perfiles se obtienen por las elevaciones de los puntajes de las distintas escalas clínicas del MMPI.

La elevación se refiere a los valores absolutos de las puntuaciones T situadas en las líneas verticales del perfil. El psicograma se traza en una hoja que tiene horizontales y puntos que corresponden a los valores de las escalas. Una línea gruesa indica la puntuación T 50 (puntuación de la media aritmética obtenida para cada una de las escalas básicas con el grupo normal que se seleccionó para la elaboración del inventario), y otras dos líneas situadas en T 30 y 70 indican puntuaciones que caen dos desviaciones estándar abajo y arriba de la media aritmética, respectivamente. De esta forma, puntuaciones superiores a la media indican grados de semejanza creciente al de los diversos grupos clínicos que se utilizaron en la elaboración de las escalas. Dentro de las líneas marcadas con 30 y 70 se encuentran los perfiles que comúnmente se han conocido con la variación de puntuación “normal”; a pesar de que las puntuaciones 30 y 70 se encuentran a la misma distancia o desviación de la media, la distribución de las escalas del MMPI tanto en la población normal como en la clínica tiende a acercarse y a pasar la línea superior (70); por lo tanto, hay una mayor frecuencia de puntuaciones elevadas superiores a 70, que puntuaciones menores que 30. Es por eso que la bibliografía es muy abundante en lo referente a interpretación de puntuaciones superiores a 70, y escasa en cuanto a la interpretación de aquellas inferiores a 30.

La elevación de las puntuaciones en el perfil es uno de los rasgos principales de la configuración del psicograma, pero también es importante la fase del perfil y sus declives. A los perfiles que están próximos a la línea horizontal T 50 se les ha denominado *perfiles de elevación normal*. Este tipo de perfiles no se encuentra en la población psiquiátrica, aunque algunos investigadores señalan que han encontrado perfiles normales en 2% de varios grupos anómalos.

Otro tipo de perfil generalmente considerado como la elevación normal es el llamado *perfil bajo o sumergido*. Las características del perfil sumergido radican en que el punto más alto superior del psicograma no pase demasiado sobre el promedio y la mayoría de las escalas tengan puntuaciones T entre 30 y 40.

El *perfil limítrofe* tiene varias de las escalas clínicas con valores T entre 60 y 70. A veces se clasifica dentro de esta categoría al perfil que tenga una sola escala con valor T de 70. Este tipo de perfil no debe tener más de dos escalas elevadas, pero si puede tener valores T superiores a 54. Dado que el perfil limítrofe se debe a que los sujetos responden de tal manera que pareciera indicar anomalías que el sujeto parece capaz de controlar, este tipo de perfil señalará las áreas en que encuentra dificultades. Sin embargo, la tendencia actual en la

interpretación del perfil se orienta más a tomar en consideración la estructura total del mismo y a darle menor importancia a elevaciones aisladas de las escalas.

El *perfil elevado* se caracteriza por tener algunas escalas en la región superior del psicograma, principalmente cuando se encuentran puntuaciones arriba de T 80. Puede ser que pocas escalas superen dicha puntuación y que las demás se encuentren en la región inferior, o que varias escalas se encuentren en la región superior del psicograma. Cuando son varias las escalas que se encuentran en la región superior se le denomina *perfil flotante*. Para ser considerado como tal, un perfil debe tener una puntuación en la escala F entre T 60 y 92, cualquiera de las escalas 1, 2 ó 3 igual o superior a T 80, y las escalas 7 y 8 iguales o mayores a T 85.

Los perfiles que tienen como punto más elevado la escala 3 (Hi) son moderados o de baja elevación. *Perfil elevado* es aquel en que existen 3 ó más escalas superiores a T 70. Cuando las escalas 7 u 8 son los puntos más elevados, los perfiles serán también los más elevados.

El *perfil tipo “punta”* se caracteriza por tener sólo una o dos escalas prominentes, en tanto que las demás permanecen casi a un mismo nivel. La finalidad de clasificar estos perfiles era distinguir a simple vista un perfil de cierto tipo de pacientes; por ejemplo, si el paciente tenía como cuadro clínico principal la depresión, se esperaba que la punta del perfil fuera la escala 2 y que las otras escalas clínicas se mantuviesen bajas, ofreciéndose así un perfil perfectamente claro y un diagnóstico preciso. No obstante, los autores de la prueba descubrieron muy pronto la rareza de los perfiles de punta en la práctica clínica; lo que más se observó en la población psiquiátrica es la configuración de varias escalas elevadas en los perfiles.

El perfil llamado *tríada neurótica* es otro tipo de perfil en el que se observa una interrelación de las escalas clínicas 1, 2 y 3 (Hs, D y Hi) en diferentes combinaciones. El grupo 1-2-3 es más frecuente en la práctica clínica que el grupo 3-2-1²; en cambio, las configuraciones 2-1-3 y 2-3-1 son las más observadas.

Otras combinaciones a las que se han referido varios autores son la 1-3-2 y la 3-1-2; en las que la escala 2 tiene media desviación estándar o más, inferior a los valores de las escalas 1 y 3. Por la forma V que las tres escalas forman se le llama el *perfil V conversivo* o *perfil V psicossomático*. Estas combinaciones de los valores de la tríada neurótica son muy útiles en la descripción e interpretación apropiada de los perfiles.

² El orden en que se anotan los dígitos que identifican las escalas señala la elevación relativa de ellas. La secuencia 3-2-1 indica que la escala 3 tiene la puntuación más alta, seguida de la 2 y ésta de la 1. En cambio 2-1-3 indica que la escala 2 tiene el puntaje más alto, la 1 el segundo más alto y la 3 el siguiente.

Una clasificación de los perfiles similar a la anterior es la *tétrada psicótica*, o relación entre las escalas que se han encontrado con mayor frecuencia en pacientes psicóticos, esto es, las escalas 6, 7, 8 y 9. Como toda esta configuración de escalas se encuentra en el lado extremo derecho del perfil y se ha observado con frecuencia la combinación de las escalas en los perfiles de psicóticos, se les llama la *tétrada psicótica* en sus diferentes combinaciones. Una de las configuraciones más importantes es la paranoide, donde las escalas 6 y 8 son los puntos más altos en la región elevada, y las 7 y 9 son un poco más bajas. De cualquier forma, conviene tomar en consideración los valores de las demás escalas del perfil.

El término *curva difásica* se refiere a los perfiles que tienen una punta en la tríada neurótica y otra en la *tétrada psicótica*. Sin embargo, se puede encontrar esta configuración en la elevación simultánea de varias escalas; así, las escalas 4 y 5 pueden ser las más elevadas en el centro, y las 9 y 0 las más elevadas en el extremo derecho del perfil. Esta curva tiene importancia diagnóstica.

La elevación relacionada de dos puntas se llama *punta doble*, y cuando está integrada por las escalas 4 y 9 en cualquiera de sus combinaciones, 4-9 o 9-4, se le llama *configuración de desorden de carácter*. Éste es un elemento en el que se puede observar la importancia de las designaciones de dos escalas, que usualmente son las más elevadas en el perfil, y generalmente es la forma más exacta de describir las características de la personalidad en lugar de las denominaciones cualitativas de la terminología del perfil. Sin duda se esclarecerá este punto cuando se discuta la configuración de dos escalas elevadas del perfil.

Otro tipo de perfil que merece un comentario es el llamado *sierra dentada*, que es una variante importante de la *tétrada psicótica*, con la escala 8 y 6 como puntos predominantes del perfil. En este perfil la tríada neurótica es menos baja que la escala 4, y la escala 2 es la punta de la tríada; en esta forma, con las escalas 2, 4, 6 y 8 en prominencia, el perfil da la impresión de los dientes de una sierra.

El término *anticlinorium* se utiliza para describir los perfiles en los que las escalas del centro son más elevadas que las de los extremos, es decir, las escalas de la tríada neurótica y la *tétrada psicótica* se encuentran en nivel inferior. El perfil presenta una curva que es prominente en la parte central; este perfil es poco usual en las poblaciones clínicas, pero muy frecuente en grupos universitarios. El perfil llamado *sinclinorium* es relativamente raro, y consiste en una curva integrada por prominencia en las escalas 1 y 9, y las otras uniformemente más bajas.

La declinación de un perfil se refiere a las elevaciones relativas de las escalas en varios lugares del psicograma. Si las escalas de la tríada neurótica son más prominentes que las demás, se forma un perfil con una declinación que va de izquierda a derecha, que algunos autores denominan declinación negativa. Cuando las escalas de la *tétrada psicótica* son las más prominentes y forman un perfil con declinación derecha izquierda, se denomina declinación positiva.

Cuando las escalas de los dos extremos tienen aproximadamente la misma elevación, se dice que el perfil tiene declinación 0 o neutral.

El uso de la declinación de las escalas del MMPI comenzó a llamar la atención de los autores de la prueba desde un principio. Actualmente se encuentra una serie de referencias en las que se le da menos atención a la interpretación aislada de las escalas clínica y mayor importancia a la combinación de dos, tres y hasta cuatro de ellas. Las escalas utilizadas aisladamente siguen siendo interpretadas por varios autores, pero con mayor frecuencia se observa que en la investigación se utiliza el método de interpretar los perfiles, pues es de gran ayuda para la interpretación clínica, ya que permite tener un cuadro diagnóstico más preciso.

Escalas Adicionales

Estas escalas se crearon para asistir en la interpretación de las escalas básicas y para aumentar el alcance clínico acerca de problemas y desórdenes de la prueba. Se puede señalar que para la interpretación de estas escalas no están especificados criterios de corte para delimitar alta o baja puntuación, sino que en general los puntajes T más altos que 65 se podrían considerar altos, y aquellos bajo 40 (siempre en puntuación T) se pueden considerar puntajes bajos. No ocurre así en la escala MAC-R, para la cual se ha especificado criterios más exactos.

A continuación aparecen las escalas adicionales más importantes en uso.

A – Ansiedad	Puntajes altos: ansiedad, inquietud emocional. Tienden a ser inhibidos, sobrecontrolados, incapaces de tomar decisiones sin vacilaciones e inseguridades. Conformistas y fácilmente alterados en situaciones sociales. Puntajes bajos: ausencia de alteración emocional. Tienden a ser enérgicos, competitivos, asertivos socialmente. Pueden no tolerar frustraciones, prefieren la acción a la contemplación.
R – Represión	Puntajes altos: convencionales, sumisos, tratan de evitar situaciones desagradables. Puntajes bajos: seguros, enérgicos, expresivos, desinhibidos e informales. Muestran entusiasmo por la vida. Emotivos, excitables, agresivos, dominantes.
Es – Fuerza del Yo	Es una medida de adaptabilidad, capacidad para movilizar recursos propios y funcionar eficientemente. Buen indicador general de salud psicológica. Puntajes altos: espontaneidad, buen contacto con la realidad, sentimientos de adecuación personal. Capaces de afrontar estrés y recuperarse de los problemas. Esta escala puede estar elevada en sujetos altamente defensivos. Puntajes bajos: inhibición, quejas de dolencias físicas, incapacidad de enfrentar la presión ambiental. Baja autoestima, dificultad para adaptarse a situaciones problema.
O-H (Hostilidad sobrecontrolada)	Puntaje altos: personas con reacciones adecuadas a las provocaciones la mayoría de las veces, pero que ocasionalmente reaccionan en forma agresiva sin provocación aparente. Puntajes bajos: puede tratarse de personas agresivas en forma crónica, tal vez adecuados en la expresión de la agresión.

MAC-R (Alcoholismo) Los puntajes altos pueden estar asociados a riesgo de o conductas adictivas.

Puntajes iguales o superiores a 28: sugieren fuertemente abuso de sustancias.

Puntajes entre 24 y 27: sugiere abuso, pero puede ser falso positivo.

Puntajes bajo 24: contraindica abuso.

Aparte del posible abuso de sustancias, los puntajes altos indican personas socialmente extrovertidas, exhibicionistas, que asumen riesgos; mientras que los puntajes bajos se asocian a timidez, introversión y falta de confianza en sí mismos.

Do – Dominio

Tendencia a ser ascendiente o controlador en las relaciones interpersonales.

Puntajes altos: seguridad, iniciativa social, perseverante, resuelto, liderazgo grupal.

Puntajes bajos: sumisos, no asertivos, fácilmente influenciados por los demás. Falta de confianza en sí mismos, con sentimientos de inadecuación.

Re – Responsabilidad Social

Puntajes altos: aceptan las consecuencias de sus actos, son confiables, poseen integridad y sentimientos de responsabilidad hacia el grupo.

Puntajes bajos: no aceptan la responsabilidad de su conducta. No son dignos de confianza, no se sienten responsables ante el grupo.

Mt – Desajuste escolar

Discrimina entre estudiantes bien adaptados y con desajuste escolar (estudiantil a nivel de college). Detecta dificultades presentes, actuales, pero no predice desajustes futuros.

Puntajes altos: probablemente tengan desajuste general, son pesimistas y ansiosos.

Puntajes bajos: adaptados, optimistas y conscientes.